

12 大きな異変

下腹部から腹部にかけて数本の褐色の線があらわれ、妊娠線といわれる。これは、最初は下の血管が映って紫色にみえるが、のちには白く光沢をもったようになる。出産がおわれば、ほとんどわからなくなる。もともと妊娠線のまったくあらわれぬ人もある。

貧血 里帰りしてはじめていった病院で血液をしらべて貧血といわれることがある。ふつうヘモグロビンが11g/dl以下を貧血にするが、妊娠の末期に10g/dlぐらいになることはめずらしくない。赤血球も400万をわるが、なれた産科医は問題にしないだろう。

12 大きな異変

大きな異変というのは、妊娠の継続をゆるさないか、場合によって母親の生命をおびやかすような事件の意味である。

妊娠前半におこる大きな異変は、どれも出血ともなうから、出血にはいつも気をつけていないといけない。これには流産と子宮外妊娠と胞状奇胎とがある。

流産は妊娠4週から11週(2〜3カ月)のあいだにおこることが多い。流産は医者からみれば病気だが、人類全体からみれば、人間という種をまもるために、失敗した受精卵を出産までもつていけないように調節する自然のいとなみとかがえられる。とういのは、自然に流産したかたまりのなかの受精卵をしらべてみると、染色体に異常のあるものが多い

へんおおいからである。こういう自己防衛的な自然流産は、受精卵の15%ぐらいにあるらしい。生理が少しおくれて、いつもよりおおかたと思うもののなかに自然流産がふくまれていると思える。だから、どんな手当をしても止められない流産というのは、はじめから失敗した妊娠である。たとえ流産をふせげても、生きていけない。胎児として死ぬか、生まれてすぐ死ぬ。

妊娠4週ないし11週で突然出血(量はいろいろ)があり、下腹部に異常感(痛みのこともあるし、はる感じだけのこともある)があつたら、まっさきに流産をかんがえねばならない。そのときすでに子宮口が開いてしまっていると、流産はさけられない。出血もおおい。だが子宮口のまだ開いていないものは、安静によって進行をとめられる(全部ではないが)。

流産の治療に合成女性ホルモンをつかった時代があつたが、生まれた子の性器に奇形ができたり、女の子は膣がんを、男の子は精子不足をおこしたりするから今はつかわない(不勉強医はつかっている)。

妊婦が出血に気づいたらどうするかだが、同時に下腹に痛みのあるときは、すぐに産科医にみてもらわないといけない。痛みのない出血でも、超音波でしらべれば、原因がわかるようになったのだから、早く受診したほうがよい。妊娠だと診断されたときに、出血の場合はどこですぐみてもらえるかを医師にたずねておくのがよい。

胎児がすでに死んでしまつて、子宮の内膜の一部がくさつたときは、おりものが褐色だ。この場合は